위축성 위염·장상피화생

위축 범위에 따라 1~2년마다 내시경을 보는 이유 — 오늘 내시경에서 위축성 위염 또는 장상피화생이라는 말을 들으셨다면, 무엇이 문제이고 왜 정기적으로 내시경을 계속 보아야 하는지 설명드립니다.

위축성 위염·장상피화생이란



아래쪽부터 점막이 얇아지고(위축)
장 점막처럼 바뀐 자리(화생)

구분	위축성 위염	장상피화생
어떤 변화	염증이 **있다 없다를 반복하며 점막이 깎여 얇아진 것**입니다. 위 몸통까지 퍼진 **개방형**부터 위암 위험이 뚜렷이 높아집니다.	위축이 진행된 자리에서 위 점막 일부가 **장 점막처럼 바뀐 상태**입니다.
아픈가요?	피부 주름처럼 **위축은 아프지 않고, 지금 속 불편함의 원인도 아닙니다.**	
연령별 유병률 (내시경 소견)	40세 미만 29.9% → **60세 이상 59.4%**	40세 미만 3.4% → **60세 이상 17.4%**

위암 위험, 얼마나 커지나요

상대적으로 보면	실제 숫자로 보면
장상피화생이 있으면 위암 위험이 올라가는 것은 맞습니다 — 국내 한 연구에서는 없는 경우보다 위암 발생이 **약 11배** 높게 나타났습니다.	원래 건강한 위에서 위암이 생길 확률이 워낙 낮아, **장상피화생이 있는 분의 대부분에서는 위암이 생기지 않습니다.** 해외 전국 병리 연구(네덜란드)에서 진단 뒤 위암 발생은 **1년에 약 0.25%(400명 중 1명꼴)**였습니다.

왜 정해진 간격으로 내시경을 보나요

정기 내시경은 **암을 막는 것이 아니라, 암이 생기더라도 이른 단계에서 빨리 찾는 것**입니다.

기준	간격	설명
국가암검진	**40세 이상 2년마다**	누구나 지켜야 하는 **최소 간격**입니다.
위축이 전정부(위 아래쪽)에만 있을 때	**2년마다**	**위축 범위에 따라 1~2년** — 위축·장상피화생이 **넓을수록 짧은 쪽**으로, **진료 때 개별적으로 정합니다.**
체부(위 몸통)·분문부(입구)까지 넓을 때(개방형)	**1년마다**	

생활습관과 헬리코박터

이렇게 하세요	믿지 마세요
• 위축의 가장 흔한 원인은 **헬리코박터균**입니다. 균까지 있으면 위암 위험이 더해지므로 **제균 치료를 적극적으로 권합니다**(장상피화생이 넓어지기 전, 일찍 할수록 좋습니다). • 위에 좋은 것을 챙겨 먹기보다, **위에 나쁜 짠 음식·탄 음식·매운 음식·술·담배**를 줄이는 것이 더 중요합니다. **진통제**는 습관적으로 드시지 마세요.	• **마·양배추즙** 등이 위축이나 장상피화생을 되돌린다는 근거는 없습니다.

검진일까지 기다리지 말고 — 바로 응급실(119)로	빨리 진료 받으세요
검은 변 · 피를 토함 — 위장 출혈 가능성	원인 모를 **체중 감소** · 음식을 **삼키기 어렵거나 걸리는 느낌**이 계속됨 · **계속되는 구토** · **어지럼·빈혈**이라는 말을 들음

진료실 설명 슬라이드(위축 정도 분류·제균 대상 자세히) — edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/atrophic-gastritis/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — ACG 위암 전암성 병변 진료지침(2025) · MAPS III 유럽·아시아 위암 감시 지침(2025) · AGA 위축성 위염 진료 업데이트(2021) · 국내 헬리코박터 파일로리 감염 진단·치료 지침(2025 개정판) · 국가암검진 위암검진 권고안 · 국내 유병률 Gut Liver 2013 · 위암 위험 11배 J Clin Gastroenterol 2008 · 개방형 위축 Digestion 2015 · 절대위험 Gastroenterology 2008

내시경 간격은 검사 소견에 따라 담당의가 개별적으로 정합니다. 본 안내는 일반 건강정보이며 개인별 진단·검사 계획을 대신하지 않습니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/atrophic-gastritis-im/